

# 골다공증·골감소 — 운동·칼슘·비타민D

골다공증은 디스크와는 다른 병입니다. 뼈의 양과 강도가 줄어 부러지기 쉬워진 상태라 아프지 않아도 관리합니다. 운동·칼슘·비타민D가 기본이고, 필요하면 치료 주사·약을 함께 씁니다.

## 🏃 내 골밀도 T점수와 뼈를 강하게 하는 운동



### T점수 읽는 법

-1.0 이상 정상 · -1.0 미만 ~ -2.5 초과 골감소 · -2.5 이하 골다공증.  
척추와 고관절 중 **더 낮은 쪽**이 내 성적입니다.

폐경 전 여성과 50세 미만 남성은 다른 기준(Z점수)으로 봅니다. 골감소라도 **골절 위험도를 계산해 높으면 약을 검토**합니다. 내 결과는 진료 때 설명해 드립니다.

뼈는 무게를 받아야 강해집니다 — 걷기와 앉았다 일어나기부터, **허리는 곧게**.

## 🚶 뼈는 무게를 받아야 강해집니다

### ✅ 이렇게 하세요

- **걷기** — 체중을 싣는 운동의 시작입니다
- **앉았다 일어나기** — 다리 근육을 쓰는 운동
- **가벼운 점프** — 골절을 겪었다면 먼저 상의
- 강도는 천천히 — 걷기만보다 **근력운동을 섞으면** 더 좋습니다

### ❌ 피하세요

- **허리를 앞으로 숙이는 굴곡 운동** — 압박골절 위험
- 윗몸일으키기 · 요가의 깊이 숙이는 자세
- 무거운 물건을 든 채 허리 숙이기
- 골밀도가 낮을수록 숙이는 동작에 더 조심합니다

## 💊 칼슘과 비타민D — 이렇게 채웁니다

| 무엇을  | 어떻게 · 기억할 것                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 칼슘   | 하루 <b>800~1,200mg</b> — 우유·치즈·멸치·깻잎 같은 <b>음식으로 먼저</b> 채우고, 모자랄 때만 보충제를 더합니다. 골다공증 약을 드시면 모자라지 않게 챙깁니다. 사골국·곰국에 뼈에 좋다고 일부러 드실 필요는 없습니다. |
| 비타민D | 검사지 정상범위 30~100(ng/mL), 목표는 진료 때 정합니다(2008년 조사: 한국 여성 93.3%가 30 미만). 하루 1,000IU를 먹으면 약 10 오르지만 사람마다 달라 다시 재 보고, 몇 달 간격 주사도 있습니다.       |

## ❓ 흔한 오해 — 치료 주사·약은 끊으면 다시 떨어집니다

| 흔한 오해                        | 바로 알기                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| "MBP(우유 단백질 성분) 영양제로 뼈를 채운다" | 작은 연구뿐이고, 골절 예방·치료제 대신은 입증되지 않았습니다.                                               |
| "비타민D만 먹으면 된다"               | 운동·칼슘이 함께 가야 하고, 필요하면 치료제를 씁니다.                                                   |
| "순한 주사니 아무 때나 끊어도 된다"        | <b>데노수맙</b> 주사는 임의로 끊으면 골밀도가 빠르게 떨어지고 척추가 여러 곳 부러질 수 있어, 끊을 때는 진료에서 다른 약으로 이어갑니다. |
| "좋아졌으니 그만해도 된다"              | 임의로 끊지 마세요. 치료 중에는 <b>1~2년마다</b> 골밀도를 다시 잽니다(보험으로 이어가려면 보통 <b>1년마다</b> ).         |

## 🚑 이럴 때는 바로 진료

- 가벼운 충격·기침·물건 들기 뒤 **갑자기 심한 허리·등 통증** · 키가 줄거나 등이 굽어질 때 · 데노수맙 주사 예정일을 놓쳤을 때(미루지 말고 연락)
- 넘어진 뒤 엉덩이·사타구니가 아파 서거나 걷기 어려움 — **고관절 골절일 수 있어 응급실로**

함께 보기 — 진료실에서 보신 설명 자료 '골다공증 환자교육' [edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/osteoporosis/](http://edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/osteoporosis/)

## 광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한골대사학회 골다공증 진료지침 2024 · Clinician's Guide to Osteoporosis (PMID 35478046) · 폐경 후 운동 메타분석 (PMID 32785775) · 척추 굴곡 운동 (PMID 6487063) · 데노수맙 중단 권고 (PMID 33103722·40057981) · 한국인 비타민D (PMID 21190984) · 칼슘·비타민D 메타분석 (Massé, BMJ 2026)

본 자료는 골다공증·골감소 관리를 위한 일반 안내입니다. 나이, 폐경 여부, 골절 경험, 복용 중인 약에 따라 운동 강도와 치료가 달라지니 진료 때 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → [edu.gwanggyobarun.com/handouts/musculoskeletal/osteoporosis-lifestyle/](http://edu.gwanggyobarun.com/handouts/musculoskeletal/osteoporosis-lifestyle/)

